Con el aval científico de:

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GUÍA DE MANEJO DE SELINEXOR

SELINEXOR

- **Oral**
- **Nuevo Mecanismo de Acción:** inhibidor de la XPO1
- **Manejo:** profilaxis antiemética y ajuste de dosis

Autoras:

- **Dra. Mercedes Gironella Mesa**
  Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona
- **Dra. Cristina Encinas Rodríguez**
  Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Coordinadora:

- **Dra. María Victoria Mateos Manteca**
  Hospital Universitario Clínico de Salamanca, Salamanca

MED-ES-2500029

ÍNDICE

1. Mecanismo de Acción de SELINEXOR

2. Indicaciones de SELINEXOR

3. Esquema terapeutico SELINEXOR

4. Consideraciones antes del tratamiento

4.1. Consideraciones al iniciar un paciente con SELINEXOR

4.2. Consideraciones durante el tratamiento con SELINEXOR

4.3. Estrategias recomendadas de doble antiemético

4.4. Ajustes de dosis

1. Mecanismo de Acción de SELINEXOR

Selinexor es un **inhibidor selectivo de la exportina 1 (XPO1)**, que es el mediador principal de la exportación nuclear de proteínas supresoras de tumores (PST), reguladores del crecimiento y ARNm de proteínas (oncogénicas) promotoras del crecimiento. La inhibición de la XPO1 por Selinexor origina una marcada acumulación de PST en el núcleo, la interrupción del ciclo celular, reducciones en varias oncoproteínas como c-Myc y ciclina D1, y la **apoptosis de las células cancerosas**.

2. Indicaciones de SELINEXOR

- En **combinación con bortezomib y dexametasona (SVd)** para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que han recibido al menos **un tratamiento previo**.
- En **combinación con dexametasona (Sd)** para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que han recibido al menos **cuatro tratamientos** y cuya **enfermedad sea resistente** al menos a dos inhibidores del proteasoma, dos agentes inmunomoduladores y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que han presentado evolución de la enfermedad en el último tratamiento.

3. Esquema terapeutico SELINEXOR

SVd

	Semana 1						
Día	1	2	3	4	5	6	7
S	S						
Selinexor							
d	d	d					

	Semana 2						
Día	8	9	10	11	12	13	14
S	S						
Selinexor							
d	d	d					

SVd

	Semana 3						
Día	15	16	17	18	19	20	21
S	S						
Selinexor							
d	d	d					

	Semana 4						
Día	22	23	24	25	26	27	28
S	S						
Selinexor							
d	d	d					

SVd

	Semana 5						
Día	29	30	31	32	33	34	35
S	S						
Selinexor							
d	d	d					

Indicaciones

Semana 1

Día	1	2	3	4	5	6	7
Sd	S		S				
	d		d				

Semana 2

Día	8	9	10	11	12	13	14
Sd	S		S				
	d		d				

Semana 3

Día	15	16	17	18	19	20	21
Sd	S		S				
	d		d				

Semana 4

Día	22	23	24	25	26	27	28
Sd	S		S				
	d		d				

Semana 5

Día	29	30	31	32	33	34	35
Sd	S		S				
	d		d				

Indicaciones

4. Consideraciones antes del tratamiento:

4.1. Consideraciones al iniciar un paciente con SELINEXOR

Asegurar que los pacientes se mantengan hidratados, bien nutridos y con niveles adecuados de energía.

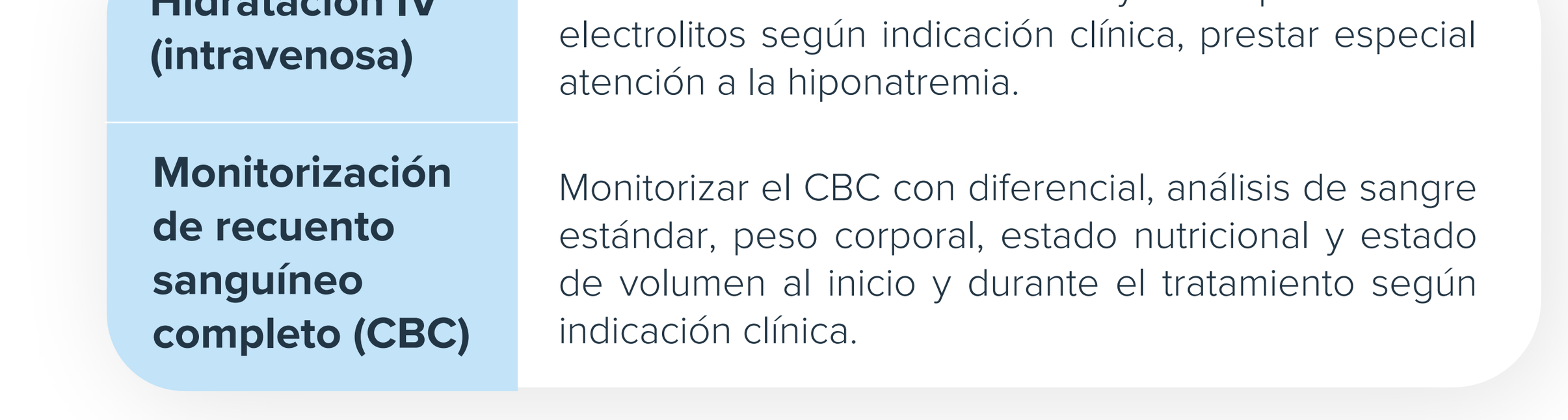
Profilaxis y Soporte	Establecer un plan de profilaxis antiemética y considerar la necesidad de profilaxis antimicrobiana. Además, planificar el manejo de trombocitopenia desde el inicio para evitar interrupciones del tratamiento.
Ingesta de líquidos	Asegurar que los pacientes mantienen una adecuada ingesta de líquidos e ingesta calórica durante el tratamiento.

4.2. Consideraciones durante el tratamiento con SELINEXOR

Monitorizar a los pacientes (p. ej., análisis de laboratorio, peso, estado nutricional) y evaluar la necesidad de modificar **la dosis** para mitigar las **reacciones adversas (ARs)**.

Hidratación IV (intravenosa)	Considerar la hidratación IV y la reposición de electrolitos según indicación clínica, prestar especial atención a la hiponatremia.
Monitorización de recuento sanguíneo completo (CBC)	Monitorizar el CBC con diferencial, análisis de sangre estándar, peso corporal, estado nutricional y estado de volumen al inicio y durante el tratamiento según indicación clínica.

Tiempo medio hasta la aparición:



Náuseas
Primera semana

Trombocitopenia
En 3-4 semanas

Monitorizar con mayor frecuencia durante los primeros **3 meses**

4.3. Estrategias recomendadas de doble antiemético

Se podrá escoger entre una de las siguientes combinaciones de profilaxis antiemética a criterio del Hematólogo:

Ondansetrón

Administrar 8 mg por vía oral, 30 a 60 minutos antes de cada dosis de selinexor, continuando con 8 mg cada 8 horas durante 2 días después de la dosis.

+

Aprepitant*

125 mg por vía oral en la mañana del día 1 y 80 mg por vía oral los 2 días siguientes a la administración de Selinexor.

Netupitant + Palonosetron*

Una vez a la semana previo a la dosis de selinexor, un comprimido oral que contiene netupitant 300 mg + palonosetrón 0.5 mg.
(Ver ficha técnica)

Ondansetrón

Administrar 8 mg por vía oral, 30 a 60 minutos antes de cada dosis de selinexor, continuando con 8 mg cada 8 horas durante 2 días después de la dosis.

+

Olanzapina

2.5 mg a 5.0 mg por vía oral el día de la dosis de selinexor y durante 2 días después de la dosis.

Uno o ambos antieméticos pueden reducirse gradualmente o retirarse después de 8 semanas de tratamiento, según la tolerancia del paciente.

Si se utiliza aprepitant o netupitant, puede ser necesario reducir la dosis de dexametasona al 50% debido a posibles interacciones medicamentosas.

*Dispensación hospitalaria

4.4. Ajustes de dosis

Las siguientes recomendaciones de **reducción de dosis de selinexor*** se sugieren para pacientes que experimentan una reacción adversa mientras toman **selinexor en combinación con bortezomib y dexametasona:**

SVd: BOSTON
Dosis inicial recomendada

100 mg una vez por semana

Primera reducción de dosis

80 mg una vez por semana

Segunda reducción de dosis

60 mg una vez por semana

Tercera reducción de dosis

40 mg una vez por semana

Suspender

Si los síntomas no se resuelven

Las siguientes recomendaciones de **reducción de dosis de selinexor*** se sugieren para pacientes que experimentan una reacción adversa mientras toman **selinexor en combinación con dexametasona:**

Sd: STORM
Dosis inicial recomendada

80 mg **80 mg** los días 1 y 3 de cada semana (**160 mg** en total por semana)

Primera reducción de dosis

100 mg una vez por semana

Segunda reducción de dosis

80 mg una vez por semana

Tercera reducción de dosis

60 mg una vez por semana

Suspender

Si los síntomas no se resuelven

*Consulte la Sección 4 de esta guía y la ficha técnica actualizada de selinexor para más detalles sobre los pasos a seguir según las ADRs específicas.

Modificaciones de dosis

Las reducciones de dosis debidas a eventos adversos tras una dosis inicial de 100 mg en el estudio BOSTON, se asociaron a una mayor eficacia, a una reducción en la tasa de EA y a una mejora en la calidad de vida.



Trombocitopenia

- La trombocitopenia es la **principal causa de modificaciones** en la dosis.
- Monitorizar con **mayor frecuencia durante los primeros 3 meses** de tratamiento.
- **Reducir la dosis, interrumplir o suspender** permanentemente según la gravedad de la reacción adversa.

25,000–<75,000/mcL

- Realizar una **primera reducción de dosis** de selinexor

25,000–<75,000/mcL con sangrado simultaneo

- **Interrumpir** selinexor
- **Reiniciar** selinexor en un nivel de dosis más bajo, **después de que el sangrado haya remitido**

<25,000/mcL

- **Interrumpir** selinexor
- **Monitorizar** hasta que el recuento plaquetario vuelva a **≥ 50.000/mcL**
- **Reiniciar** selinexor en un nivel de dosis más bajo

Población anciana

No se requiere un ajuste de dosis de selinexor por **edad del paciente**.

Insuficiencia renal

No se requiere ajuste de dosis de selinexor en pacientes con insuficiencia renal **leve, moderada o severa**.

En pacientes con insuficiencia renal dependiente de hemodiálisis los **regímenes** con selinexor son en general **tolerables** basados en los resultados de una cohorte de vida real.

Insuficiencia hepática

No se requiere ajuste de dosis de selinexor en pacientes con insuficiencia hepática **leve**.

No se dispone de evidencia suficiente en pacientes con insuficiencia hepática **moderada o severa** para establecer una recomendación de dosis.

Administración oral: tragar entero con un vaso de agua

No triturar, partir, masticar ni dosificar el comprimido para evitar riesgo de **irritación de la piel** por el principio activo.

Puede tomarse **con o sin comida**.

El comprimido es azul, redondo, biconvexo, de 4 mm de grosor y 7 mm de diámetro, con "K20" grabado en una de sus caras.

Referencias

GUÍA DE MANEJO DE SELINEXOR

MENARINI group

Stemline®
A Menarini Group Company